FESTINA LENTE
CONSULTING

Documento para el panel de expertos

Respuesta a los comentarios del panel: revisión 1 del manuscrito

Cliente:	Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y metabolismo (ACE)
Asunto:	Declaración de posición sobre hipoparatiroidismo crónico en Colombia
Dirigida a:	Panel de expertos
Fecha de entrega:	07/11/2026
Contacto para inquietudes:	Carlos E. Builes Montaño | cbuiles@festinalente.cc

Gracias por la revisión del primer borrador. Recibimos 43 comentarios de tres panelistas en el documento y observaciones adicionales por mensajes. Todos se incorporaron. Esta matriz resume cada comentario, la respuesta del equipo coordinador y el cambio hecho en el manuscrito, que se adjunta. Siglas: LFFM, L.F. Fierro-Maya; NAH, N. Aristizábal-Henao; AFGR, A.F. García-Ramos; AMT, A. Moreno-Torres. Los comentarios repetidos se agruparon.

Cambio principal: mal control y limitaciones

El mal control se define solo por los dominios de la Tabla 1. Las limitaciones del tratamiento (intolerancia persistente y malabsorción comprobada) no son dominios: justifican evaluar el reemplazo con PTH solo cuando persiste al menos un dominio. Candidato = dos o más dominios, o un dominio con una limitación. La dosis alta pasa a un punto de buena práctica. Como esto precisa lo votado en D4a–D4c sin volver a votar, se reporta como desviación del protocolo.

1. Mal control y limitaciones del tratamiento (antes «Ruta B»)

Revisor	Comentario	Respuesta y cambio en el manuscrito
LFFM	La carga terapéutica, la intolerancia y la malabsorción se votaron como factores que limitan la terapia convencional, no como indicación. Con la redacción, un paciente con calcio en metas e intolerancia sería candidato. Lo mismo aplica a la Figura 1.	Aceptado. El manuscrito separa ahora dos conceptos: el mal control se define solo por los dominios (Tabla 1) y las limitaciones del tratamiento no son dominios. Se eliminaron las «rutas».
NAH	Anclar la cantidad de calcio requerida a la intolerancia y la malabsorción comprobada («con» en lugar de «o»), para que la dosis no quede como criterio independiente.	Aceptado. La dosis alta (calcio elemental >3 g/d con cualquier dosis de calcitriol, o calcitriol >2 µg/d con cualquier dosis de calcio) pasa a un punto de buena práctica (Recuadro 2): obliga a revisar el tratamiento y a buscar malabsorción, pero no es indicación por sí sola.
AFGR	D4a–D4c se votaron «como fundamento para evaluar reemplazo con PTH», pero el ítem no decía si bastaban solas. Propone resolverlo (limitación + al menos un dominio, entre otras opciones) y que el resumen diga que es la parte menos estable.	Aceptado. Candidato = dos o más dominios persistentes, o un dominio persistente con una limitación (intolerancia persistente o malabsorción comprobada). Una limitación sin ningún dominio no basta. Como esto precisa lo votado sin volver a votar, se reporta como desviación en Métodos y en Limitaciones. El resumen, Resultados y Discusión señalan que carga e intolerancia fueron lo menos estable en los análisis de sensibilidad.
LFFM, AMT (mensajes)	El paciente debe cumplir criterios de mal control. ¿La cirugía digestiva (bypass, pancreatoduodenectomía) podría ser por sí	La cirugía digestiva sola no basta: la malabsorción debe ser comprobada (causa estructural más evidencia funcional) y, como limitación, exige además al menos un

Revisor	Comentario	Respuesta y cambio en el manuscrito
	sola un criterio?	dominio. Se añadió la pancreatoduodenectomía a la Tabla 2.

2. Hipocalcemia: meta y umbral

Revisor	Comentario	Respuesta y cambio en el manuscrito
LFFM	Retirar «sin hipercalcemia» y proponer una meta de 8,0–8,5 mg/dL. ¿Un calcio de 8,2 mg/dL contaría como hipocalcemia? Recuerda que se acordó definir hipocalcemia como calcio <8,0 mg/dL.	Aceptado. Meta de 8,0–8,5 mg/dL con calcio corregido (o iónico en la parte baja del rango) en el Recuadro 1. El dominio de hipocalcemia es calcio corregido <8,0 mg/dL o iónico por debajo del límite inferior (Tabla 1), sin superposición con la meta. Según la síntesis de la reunión, el umbral no se votó; queda como punto que el panel aprueba en esta revisión.
AFGR	Apoya la meta 8,0–8,5 y el dominio <8,0; pide armonizar la Tabla 1 (8,0–8,3) y la Discusión (8,0 y 8,2).	Aceptado y armonizado en la Tabla 1, el Recuadro 1 y la Discusión.

3. Formulaciones de PTH

Revisor	Comentario	Respuesta y cambio en el manuscrito
LFFM, NAH, AFGR	La formulación debe limitarse a productos con evidencia de ensayos clínicos en hipoparatiroidismo crónico; mencionar la teriparatida fuera de indicación.	Aceptado. Alcance: «formulaciones de PTH con evidencia de ensayos clínicos en hipoparatiroidismo crónico». La teriparatida fuera de indicación queda fuera de esta definición y debe justificarse caso a caso. Es compatible con D5, que votó que los criterios no dependan de un producto.

4. Definición de intolerancia

Revisor	Comentario	Respuesta y cambio en el manuscrito
LFFM, AFGR	La hipercalcemia y la hipercalciuria no son intolerancia (son dominios); la referencia de Prince 2006 no sostiene la afirmación.	Aceptado. Intolerancia = efectos adversos no metabólicos, sobre todo gastrointestinales, que persisten pese a la optimización. Se retiró la referencia de Prince 2006.

5. Lista de optimización (Recuadro 1)

Revisor	Comentario	Respuesta y cambio en el manuscrito
NAH	Añadir el producto calcio × fósforo; especificar «calcio elemental» en la dosis por toma.	Aceptado. Ca × P ≤55 mg^2/dL^2 en el Recuadro 1; «500 mg o menos de calcio elemental por toma».
LFFM (mensajes)	Faltó el calcio de la dieta de 1000 a 1200 mg/día.	Aceptado. Añadido al Recuadro 1 y a las causas corregibles del paso 2.
AFGR	KDIGO dejó de usar Ca × P; con calcio de 8,5 el fósforo debe superar ~6,5 mg/dL para cumplir el dominio; definir «muestra adecuada».	Aceptado. Nota en la Tabla 1 (KDIGO 2017, rara vez se cumple) y definición de muestra adecuada: en ayunas, sin hemólisis y sin torniquete prolongado.

6. Definiciones operativas (Tabla 1)

Revisor	Comentario	Respuesta y cambio en el manuscrito
AFGR	Dominios que pueden contarse dos veces (hipocalcemia + intensificaciones; hipercalciuria + litiasis).	Se aclaró en una nota que se votaron como dominios separados y cuentan por separado; su coexistencia suele reflejar enfermedad más grave. Punto para aprobación del panel.
AFGR	La oscilación entre hipocalcemia e hipercalcemia no queda en ningún dominio.	Aceptado. Se menciona en la Tabla 1 como situación que se valora clínicamente.
AFGR	Exigir al menos tres valores de TFG en ≥12 meses para la pendiente y citar KDIGO.	Aceptado. Añadido a la Tabla 1 y a la Discusión, con la referencia de KDIGO 2024.
AFGR	La mayoría no tiene imagen renal basal: definir qué hacer y recomendar ecografía basal.	Aceptado. Se recomienda ecografía renal basal al cronificarse el hipoparatiroidismo; sin imagen basal, un primer hallazgo no puede fecharse y se interpreta con la historia de calciuria.

7. Presentación

Revisor	Comentario	Respuesta y cambio en el manuscrito
NAH, AFGR	La Tabla 3 es difícil de leer: usar símbolos, agrupar y simplificar; la portada anuncia dos figuras y hay una.	Aceptado. Tabla 3 agrupada por tema, con ✓ / ? / × y una columna que indica cómo se usa cada ítem en la declaración. Nueva Figura 2: medianas por ítem en las rondas 1 y 2.
AFGR	En la Figura 1 la flecha «neither route met» sale solo de una ruta.	Resuelto con la nueva Figura 1, un árbol de decisión: ¿cuántos dominios persisten? Dos o más → evaluar; uno → ¿hay limitación?; ninguno → continuar terapia optimizada.
NAH	Añadir «with» en el resumen y en la definición de candidato.	Resuelto con la nueva definición (un dominio con una limitación).

8. Proceso del panel

Revisor	Comentario	Respuesta y cambio en el manuscrito
LFFM (mensajes)	Papel de los panelistas que no asistieron a la reunión y perspectiva desde la que votaron; oportunidad pedagógica sobre una terapia de muy alto costo.	Limitaciones describe que los dos panelistas que no asistieron recibieron la síntesis y contribuyeron solo con sus valoraciones. Los cuatro endocrinólogos fueron los cuatro asistentes, por lo que el análisis por asistencia es también el análisis por especialidad; el subgrupo de dos panelistas no se reporta para no revelar valoraciones individuales. La Discusión enfatiza la optimización del tratamiento convencional y la selección explícita de pacientes.
LFFM, AFGR	Declaración de conflictos: especificar la compañía relacionada con PTH.	Actualizado en Declaraciones con la compañía indicada.

Puntos que el panel debe aprobar en esta revisión

- La nueva definición de candidato: dos o más dominios, o un dominio con intolerancia persistente o malabsorción comprobada; la dosis alta como punto de buena práctica (Recuadro 2).
- La meta de calcio de 8,0–8,5 mg/dL y el dominio de hipocalcemia por debajo de 8,0 mg/dL.

- Las definiciones operativas de intolerancia y de malabsorción comprobada (Tabla 2).
- Las listas de verificación (Recuadros 1 y 2) y las notas operativas de la Tabla 1.
- La redacción del alcance sobre formulaciones de PTH y teriparatida fuera de indicación.

Agradecemos enviar la aprobación o los comentarios sobre estos puntos. Después de la aprobación del panel, el documento se compartirá con los miembros de la ACE para comentarios cualitativos.

CONFIDENCIALIDAD

La presente información se entrega con el entendimiento de que será manejada bajo estricta confidencialidad. La información no deberá ser revelada, duplicada o usada en su totalidad ni parcialmente, para ningún otro propósito que no sea la evaluación de este material al interior de Festina Lente y la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo. De ninguna manera los asuntos descritos en este documento pueden ser revelados a otras personas, excepto aquellas que sean aprobadas de forma explícita por Festina Lente.

¡Gracias por confiar en nosotros!